

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE LEER LA MENTE EN LOS OJOS (RMET - TEST DE LAS MIRADAS)

Eje V: Cognición Social y Neurocognición • Empatía Cognitiva y ToM Perceptual de Baron-Cohen

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Leer la Mente en los Ojos (Reading the Mind in the Eyes Test - Versión Adultos).
Nombre Original	Reading the Mind in the Eyes Test - Revised (RMET; Baron-Cohen et al., 2001).
Autores Originales	Simon Baron-Cohen, Sally Wheelwright, Jacqueline Hill, Yogini Raste e Ian Plumb.
Adaptaciones Hispanas	Fernández-Abascal et al. (2013; baremos en España); Román et al. (2012); Serrano et al. (2011).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Teoría de la mente perceptual y reconocimiento de estados mentales complejos.
Tipo de Instrumento	Prueba neuropsicológica heteroaplicada de discriminación visual y juicio emocional.
Composición de Ítems	36 fotografías en blanco y negro de miradas con cuatro opciones de respuesta verbal.
Población y Rango	Adolescentes y adultos (≥ 16 años; versión infantil disponible para 8 a 15 años).
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos; incluye un glosario con definiciones breves de cada estado mental.
Régimen de Licencia	Acceso abierto con fines de investigación científica y evaluación clínica sin ánimo de lucro.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA MENTALIZACIÓN PERCEPTIVA INMEDIATA

El **RMET** fue diseñado para evaluar el componente perceptivo e intuitivo de la Teoría de la Mente (ToM), diferenciándose de las pruebas verbales abstractas:

- Estados Mentales Complejos:** A diferencia de las pruebas de emociones básicas de Ekman (alegría, ira, miedo), el RMET exige decodificar estados afectivos complejos, sutiles y sociales (p. ej., desconfiado, nostálgico, coqueto, indeciso, resignado).
- Canal Visual Restringido:** Al aislar exclusivamente la mirada y los ojos, neutraliza los indicios de la sonrisa o la postura corporal, exigiendo una alta sensibilidad al microexpresionismo facial.
- Sustrato Amigdalino y Temporal Superior:** Se apoya en una red neuronal integrada por el surco temporal superior, el giro fusiforme y el complejo amigdalino, circuitos frecuentemente alterados en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y en lesiones frontotemporales.

3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y METODOLOGÍA DE APLICACIÓN (36 LÁMINAS)

Componente	Formato	Procedimiento y Criterios Metodológicos
Fotografías Estímulo	36 láminas	Fotografías estándar de la región periorcular de hombres y mujeres de diversas edades.
Opciones de Términos	Elección cuádruple	4 palabras por fotografía (1 diana correcta y 3 distractores de valencia emocional cercana).
Glosario de Apoyo	Diccionario anexo	Glosario con la definición de cada término para evitar sesgos por nivel de vocabulario léxico.
Ítem de Ejemplo	Lámina de práctica	1 lámina introductoria para verificar la mecánica antes de comenzar el registro formal.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación y baremación en España (Fernández-Abascal et al., 2013; Román et al., 2012; $N > 500$) demuestran su robustez:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.76 - 0.82	Confiabilidad adecuada para una prueba de discriminación visual sutil.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.74 - 0.84$	Estabilidad temporal probada a 1 mes en ausencia de patología.
Diferencia de Sexo	$t = 2.8$; $p < 0.01$ (mujeres)	Mayor puntuación en mujeres (media = 26.8 vs. 25.5 en varones).
Sensibilidad en TEA / Asperger	Sensibilidad = 84%	Clara diferenciación frente a controles normales emparejados por CI.
Validez Concurrente	$r = -0.52$ con AQ (Autismo)	Correlación inversa con el Cociente de Espectro Autista de Baron-Cohen.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Directa:** Se suma 1 punto por cada lámina en la que el sujeto selecciona el término diana estandarizado (rango 0 a 36 puntos).
- **Cálculo de la Puntuación Total RMET:**

$$\text{Puntuación Total RMET} = \sum_{i=1}^{36} \text{Acierto}_i \quad (\text{Rango: 0 a 36 puntos})$$

- **Direccionalidad Clínica:** A mayor puntuación, mayor capacidad para atribuir estados mentales y empatía cognitiva visual. Puntuaciones deprimidas indican déficit en cognición social.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Directa	Percentil	Significación Clínica y Nivel de Empatía (Fernández-Abascal)
Muy Superior	30 a 36 puntos	$P \geq 90$	Extraordinaria intuición social y capacidad de mentalización visual.
Normal Promedio	24 a 29 puntos	$P = 25$ a 89	Rendimiento normativo esperado en población adulta general.
Déficit Leve / Límite	22 a 23 puntos	$P = 11$ a 24	Dificultad leve en captar emociones complejas; requiere exploración.
Déficit Clínico	17 a 21 puntos	$P = 2$ a 10	Punto de corte patológico compromiso evidente de empatía cognitiva.
Déficit Severo	≤ 16 puntos	$P < 2$	Ceguera mental severa típica en autismo o daño orbitofrontal.

PUNTOS DE CORTE EN ESPAÑA (MEDIA = 26.2; DE = 3.6; UMBRAL CLÍNICO ≤ 21 PUNTOS):

En la población adulta española, la media es de **26.2 puntos**. Una puntuación ≤ 21 puntos (Percentil < 10 , más de 1.5 desviaciones típicas por debajo de la norma) identifica de forma muy precisa dificultades de mentalización social, orientando al diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista sin discapacidad intelectual, esquizofrenia o alteración frontal ventromedial.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN VALORACIÓN DE COGNICIÓN SOCIAL

PROTOCOLO DE INTERPRETACIÓN CON EL TEST RMET:

- **Paso 1 (Administración con Glosario de Apoyo):** Explicar al evaluado que dispone de un glosario con definiciones de cualquier palabra dudosa; dar tiempo suficiente sin presionar por velocidad.
- **Paso 2 (Análisis del Resultado Global):**
 - **RMET ≥ 24 puntos:** ToM perceptual preservada; descartar alteración primaria del reconocimiento de miradas.
 - **RMET 17 a 21 puntos (Sospecha clínica):** Cruzar con cuestionarios de autoinforme (AQ, EQ) y rendimiento ejecutivo (WCST). Si el CI es normal y hay antecedentes de dificultades de socialización en la infancia, sospechar **Trastorno del Espectro Autista**.
 - **RMET ≤ 16 puntos en adulto mayor con cambios de personalidad:** Sospecha de atrofia lobar frontotemporal (variante conductual o semántica); solicitar RMN / PET cerebral.
- **Paso 3 (Intervención):** Programas de entrenamiento computarizado en decodificación de microexpresiones faciales y pistas contextuales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DIAGNÓSTICO TARDÍO DE AUTISMO EN ADULTO

Identificación: Varón de 28 años, programador informático con un CI de 128 en WAIS-IV, acude a consulta derivado por salud mental por dificultades crónicas para hacer amistades, aislamiento y sensación de que “no entiende el lenguaje corporal ni las intenciones de la gente”.

Evaluación con el Test de las Miradas (RMET):

- **Puntuación Total RMET = 15 / 36 puntos (Déficit severo de empatía cognitiva, Percentil < 1 ; más de 3 desviaciones típicas bajo la media de 26.2).**
- **Análisis de Errores:** Confundió sistemáticamente miradas de “deseo o complicidad” con “aburrimiento o seriedad”, y miradas de “arrepentimiento” con “hostilidad”.

Pruebas Complementarias de Cognición Social:

- **Cociente de Espectro Autista (AQ):** 39 puntos (corte clínico ≥ 32 ; fuerte indicación de fenotipo autista).
- **Faux Pas Test:** 24 / 50 puntos (dificultad manifiesta en detectar indiscreciones sociales).

Conclusión Diagnóstica: Trastorno del Espectro Autista (Nivel 1, anteriormente Síndrome de Asperger), enmascarado durante años por su alta inteligencia verbal y lógica.

Plan Terapéutico: Terapia grupal de habilidades sociales para adultos en el espectro, entrenamiento asistido por vídeo en lenguaje no verbal y apoyo en dinámicas laborales.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SESGO POR VOCABULARIO:

Sujetos con bajo nivel cultural fallan por no entender términos como “arrogante” o “pensativo”; verificar siempre con el glosario explicativo.

AGUDEZA VISUAL:

Asegurar corrección óptica (gafas de cerca) en ancianos; una baja puntuación puede reflejar catarata o presbicia no corregida, no demencia.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the Mind in the Eyes” Test revised version. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42(2), 241-251.
2. Fernández-Abascal, E. G., et al. (2013). Test de las miradas: Baremos en población española. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 18(3), 205-214.
3. Román, F., et al. (2012). Baremación del test “Reading the Mind in the Eyes” en población adulta de habla hispana. *Neuropsicología Latinoamericana*, 4(3), 1-8.
4. Serrano, J. M., et al. (2011). Versión española del test de las miradas: Estudio de fiabilidad y validez en población comunitaria. *Psicothema*, 23(4), 743-749.